ONEMA-POP-002 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

ONEMA-POP-002 — Raciocínio Clínico no Manejo da Elevação

Importante da Pressão Arterial via Telenfermagem

Objetivo

1. Diferenciar elevação pressórica sem sinais de lesão aguda de órgão-alvo de quadro potencialmente emergencial e

orientar reavaliação/encaminhamento apropriados.

Abrangência e competência

1. Atendimento remoto por enfermeiro habilitado, respeitando limites da telenfermagem; não substitui avaliação

presencial ou serviço de emergência quando indicado.

Materiais e recursos

1. Dispositivo com acesso seguro à Carteira Digital ONEMA e telefone

2. Aparelho de pressão validado e manguito adequado, quando disponível com paciente/cuidador

3. Registro de medidas prévias e lista de medicamentos prescritos, se disponíveis

Preparação

1. Verificar conexão, identificação, consentimento/condições de privacidade, endereço para emergência e

disponibilidade de comunicação de contingência.

2. Não exigir que o paciente adquira materiais para uma triagem urgente.

Execução técnica — sequência padronizada

1. Confirmar identidade, endereço e telefone, verificar sintomas atuais e se a pessoa está acompanhada.

2. Solicitar valor, horário e contexto da PA; identificar aparelho, local de aferição, posição, repouso e adequação do

manguito.

3. Quando seguro e possível, orientar nova aferição após repouso, com braço apoiado à altura do coração, sem falar,

registrando os dois valores e os horários.

4. Investigar imediatamente dor torácica, falta de ar, déficit focal, confusão, síncope, alteração visual importante e outros

sinais de lesão aguda de órgão-alvo.

5. Se houver sinais de emergência ou instabilidade, orientar SAMU 192 e não retardar transferência por medidas

repetidas.

6. Na ausência de sinais emergenciais, revisar histórico de hipertensão, medicamentos prescritos, adesão, doses

esquecidas, sintomas e fatores circunstanciais, sem sugerir ajuste ou dose extra automática.

7. Definir encaminhamento e prazo de reavaliação conforme avaliação individual, persistência dos valores e plano

assistencial; orientar sinais de alarme.

8. Documentar técnica e fonte das medidas, resultados, sintomas positivos/negativos, avaliação, encaminhamento,

orientações e compreensão.

Intercorrências, interrupção e escalonamento

1. Sintomas compatíveis com lesão aguda de órgão-alvo, independentemente de número isolado de PA: emergência.

Não recomendar redução rápida de pressão por conta própria.

2. Se a comunicação cair durante situação crítica, utilizar os contatos de contingência disponíveis e documentar as

tentativas; não registrar falsa confirmação de socorro.

Cuidados posteriores e continuidade

1. Confirmar entendimento do plano, orientar acompanhante/responsável quando apropriado e registrar destino do

encaminhamento se confirmado.

2. Na modalidade presencial, portar esfigmomanômetro validado, estetoscópio, termômetro e oxímetro; aferir conforme

indicação clínica.

Registros na Carteira Digital ONEMA

1. Registrar data e horário, identificação profissional, modalidade, informações e respectivas fontes, sinais e sintomas,

avaliação, diagnóstico e planejamento de enfermagem quando aplicáveis, ações, alertas, contatos, resposta e

continuidade.

2. Preservar a trilha de auditoria; a Kary pode organizar dados, mas não diagnosticar, prescrever ou decidir alta.

Referências técnicas

1. COFEN, Resolução 736/2024 — https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/

2. AHA, Management of Elevated Blood Pressure in the Acute Care Setting, 2024 —

https://professional.heart.org/en/science-news/management-of-elevated-blood-pressure-in-the-acute-care-setting